学会シンポジウム

臨地実習シンポジウム

「これからの臨地実習指導における課題と展望」

本シンポジウムは、新カリキュラム下における臨地実習の現状と課題を整理することを目的としています。現在、学生を受け入れる現場の負担や指導法の格差、養成校側が期待する到達レベルなど、双方の間には少なからず認識のギャップが存在しています。

そこで本企画では、養成校と臨地側の双方から実習指導の現状や葛藤をご発表いただき、相互理解を深めます。その上で、双方にとって持続可能で効果的な実習指導・評価のあり方について、多角的に議論する場といたします。

開催日時　2026年11月01日（日）9:00～10:30

会場　第１会場（1F メインホール）

座長　藤田　孝　中部大学
帖佐 光洋　修文大学

1. 養成校の視点

演者：　萩原 和美　岐阜医療科学大学

2. 生理検査の視点

演者：　大向 千恵子　社団法人石川勤労者医療協会 城北病院

3. 検体検査の視点

演者：　亀山 拓哉　島田市立総合医療センター

4. 細菌検査の視点

演者：　海住 博之　三重県立総合医療センター

5. 病理検査の視点

演者：　福田 弘幸　市立砺波総合病院

6. 検査センターおよび健診センターの視点

演者：　佐藤 文明　株式会社グッドライフデザイン

養成校の視点

養成校における臨地実習前技能修得到達度評価の取組と課題

萩原 和美（岐阜医療科学大学）

2022年度入学生からの新カリキュラムでは、臨地実習12単位のうち1単位を「臨地実習前技能修得到達度評価」とし、実習前の技能・態度を確認する実技試験と指導に充てることとされた。本学では多数の学生を限られた時間で評価するため、日本臨床検査学教育協議会の学術委員会が作成した課題項目（A～C項目および共通項目）を参考に、実習前に特に確認すべき項目を選択し、外部評価者3名を加えて技能試験を行っている。公平性を保つため、受験者を午前・午後に分け、情報交換を防ぐよう会場と動線を構成する。また試験後から実習開始までを補講期間とし、修得が不十分な学生や技能の向上を希望する学生に追加指導を行い、実習への準備を支援している。

一方、生理学的検査では被検者の確保や繰り返し検査を受ける負担が課題となる。学内で確認できるのは実習の前提となる技能・知識であり、患者対応や状況に応じた判断には臨地での経験が欠かせない。必ず実施する項目でも、実施回数や患者を対象とする機会は施設により異なり、学生の経験に差が生じる。本発表では本学の技能試験を紹介し、学生の到達状況を受入施設と共有したうえで、臨地での学びを充実させるための課題を考える。

生理検査の視点

少数精鋭の生理検査室における臨地実習の現状と課題
～院内リソースと待機時間を活用した持続可能な指導への工夫～

大向 千恵子（社団法人石川勤労者医療協会 城北病院）

【目的】当院検査部は23名、うち生理検査室は5名で構成され、多忙な日常業務の傍ら毎年2名の大学臨地実習生を受け入れている。生理検査は患者と直接接するため指導に多くの労力を要する。本発表では、限られた人員体制における生理検査実習の現状と、当院での具体的な対策を報告する。
【現状と課題】5名体制のうち、実際に当日のルーチン業務に従事できるのは常時2~3名であり、この極めて限られた人員で通常業務と実習指導を両立させることは、指導技師への業務負担が非常に大きい。また医療安全や接遇への配慮、検査機器の制約から、十分な実技指導時間の確保が困難な点が課題であった。
【対策】指導者が業務で対応できない時間は自習とし、当院の心電図症例の判読を行わせ、空き時間に指導者が答え合わせを行う仕組みを構築した。さらに、職員の健康診断を利用し、当院職員を対象とした、心電図検査や肺機能検査の実践実習を実施した。これらにより、日常業務への支障を最小限に抑えつつ、質の高い実技・臨床教育の機会を確保した。
【結語】多忙な業務下でも、院内リソースや空き時間を有効活用することで効果的な実習が可能である。実習での生きた臨床経験が、学生の国家試験受験への強い励みやモチベーションとなるよう、今後も持続可能で教育効果の高い実習プログラムを模索し続けたい。

検体検査の視点

検体検査における臨地実習の現状と課題

亀山　拓哉（島田市立総合医療センター）

近年、検体検査部門では、分析装置の自動化・省力化が進み、業務の効率化が図られている。これらは、業務に携わるスタッフの負担軽減に大きな効果をもたらす一方で、臨地実習においては、学生が検査業務に直接関わる機会が減少し、装置や検査工程を見学することを中心とした「見学型実習」となりやすいことが課題となっている。

自動化された検査室では、検体を装置に架設するだけで検査結果が得られるように見える。しかし実際には、装置のメンテナンスや精度管理、キャリブレーション、異常値の確認、再検の判断、パニック値報告など、さまざまな業務が行われている。そのため、臨地実習では、単に自動化された検査工程を見学させるのではなく、その工程の中で臨床検査技師がどのように品質を保証し、結果を臨床へつなげているのかを学ぶことが重要である。

自動化された検査室だからこそ、検査結果を確認・評価し、必要な対応を判断する臨床検査技師の役割に目を向けさせる「考え、判断する実習」への転換が必要である。

細菌検査の視点
微生物検査の視点から

海住 博之（三重県立総合医療センター）

微生物検査は、塗抹・培養同定・薬剤感受性・遺伝子検査を駆使し、採取検体や患者背景を考慮しながら感染症の原因菌を検索する検査である。養成校では各検査の知識（点）を学ぶが、実際の臨床現場で検査の進め方を体験し、それらを線として結びつけるのが臨地実習の大きな役割である。しかし、施設規模や導入装置、試薬環境の違いなどにより、検査の実際や進め方は施設間で異なるのが現状である。

今回、微生物検査における実習指導の現状とボトルネックを整理し、当院の状況を踏まえながら、これからの効率化や標準化に向けた課題について考察する。

病理検査の視点
手技・技術習得の比重が大きい現場での指導法と若手指導技師の育成

福田 弘幸（市立砺波総合病院）

病理検査部門では、切り出し補助・薄切・染色・封入など、各工程が手技に直結しており、実践的な指導への依存度が高い。なかでも薄切は、不可逆的な検体を扱うこと、力加減や刃の角度など感覚に依存すること、手元の微細な動きを可視化しにくいこと、診断精度に直結することから、習得に高度な技術を要する。一方、臨地実習では、指導ノウハウがベテランの暗黙知として個人に偏在し、指導者によって教え方や評価が異なる「属人化」や、教える経験のない若手指導技師の育成停滞という課題がある。本発表では、①薄切工程を細分化し、手元の動きを動画で可視化するとともに重要なポイントを言語化した「動画付き統一教育教材」の整備、②動画視聴、不安や疑問の聴取、ダミー検体での練習を経て本検体へ移行する段階的教育、③終業前10分に若手指導者とベテランが当日の指導を言語化する「ふりかえり」を習慣化し、指導実績を評価につなげる仕組み、の3本柱を提案する。これにより、手技指導を個人の経験や力量に依存するものから組織的な仕組みへ転換し、誰が教えても一定の質を保てる実習環境と、若手が教える経験を通じて成長できる教育体制の構築を目指す。

検査センターおよび健診センターの視点
登録衛生検査所における臨地実習のあり方を考える
―検査センターだからこそ提供できる学び―

佐藤 文明（株式会社グッドライフデザイン）

当施設は登録衛生検査所として、隣接する病院からの要請を受け、昨年より臨地実習生の受け入れを開始した。受け入れ期間は短く、また臨地実習指導者の有資格者も不在であることから、限られた期間の中で何を学び、どのような到達目標を設定すべきか、教育内容を十分に体系化できていないことが課題である。さらに、病院に隣接しているものの、登録衛生検査所という特性上、患者背景や診療過程を直接把握する機会が限られており、検査データを臨床と結び付けて考える教育には一定の限界がある。

一方、当施設ではインターンシップも受け入れており、職業・職場の理解や職業適性の確認を図るインターンシップと、臨床検査技師教育の一環として学修する臨地実習との目的の違いを、実際の教育内容に十分反映できているかについても検討が必要である。

しかし、検査センターには、多数の検体を正確かつ効率的に処理するための業務設計、精度保証、業務改善など、病院実習とは異なる学びを提供できる強みがあると考えている。今後、登録衛生検査所が担うべき臨地実習の役割と教育内容を明確にし、限られた実習期間においても学生にとって有意義な学修機会となる体制について検討したい。